

■ 脳卒中／危険因子

不安障害・PTSDは初発脳卒中の危険因子か 1,118万人を統合

PTSDでHR1.50、不安障害でHR1.29 出血性は有意に届かず

不安障害やPTSDがある人は、初めての脳卒中を起こしやすいのか。2026年1月1日までの文献から、不安障害・強迫症(OCD)・PTSDと初発脳卒中の関連を見た縦断コホート研究23本、計11,181,338人を統合したメタ解析がJournal of Affective Disordersに出た。

臨床診断された不安障害の初発脳卒中ハザード比(HR)は1.29(95%CI 1.14～1.46)、PTSDは1.50(同1.31～1.72)で、両者を合わせるとHR1.38(同1.28～1.50)だった。型別では虚血性がHR1.34(同1.13～1.58)、出血性は1.24(同0.95～1.62)で有意に届かなかった。強迫症は1研究のみで統合せず。心血管リスク

因子とうつ病で調整後も関連は残った。

観察研究の統合で、因果は言えない。著者は「血管リスクのマーカーかもしれない」とし、因果の確認はこれからとする。回復期では発症後の症例を扱うが、発症前の精神科の既往や治療歴を聞き取る意味づけの材料にはなる。



発症前の心の既往も、脳卒中の背景を読む手がかり

出典 [J Affect Disord](#) ↗

数字で見る

23研究

統合したコホート研究

1,118万人

対象者の合計

1.50

PTSDの脳卒中HR

■ 心臓リハ／呼吸

心臓外科後のリハ、呼吸訓練器の上乗せ効果なし 46人のRCT

心臓外科後の入院患者46人を、インセンティブスパイロメトリ(IS)+心臓リハ群と心臓リハのみの群に割り付けたブラジル2病院のRCT。どちらも1日2回、リハは2～4METsの7段階で行い、術後肺合併症・6分間歩行・握力・呼吸筋・在院日数を評価した。

術後肺合併症も握力も群間差はなく、在院日数の差は-1日(95%CI -4.71～2.71)で有意ではなかった。両群とも術後



に呼吸筋力と歩行距離が低下した。人工心肺時間はIS群が有意に長い。46人と小規模で、「効かない」の証明ではなく「差が見えなかった」と読むのが妥当だ。

出典 [Physiother Res Int](#) ↗

■ 心臓リハ／身体活動

心臓リハ参加者で24時間ガイドラインの3基準を満たしたのは2.9%

心臓リハ参加者105人(平均68.5±10.2歳、58.1%が冠動脈疾患)で、身体活動・座位行動・睡眠を加速度計で、QOLをSF-36で測った横断研究。カナダ24時間運動ガイドラインの3推奨をすべて満たしたのは2.9%で、個別では身体活動29.5%、座位行動9.5%、睡眠34.3%だった。

身体活動が多いほど機能的能力・活力・社会面が良好で、座位行動が多



いほど機能的能力が低かった。睡眠時間はQOLと関連しなかった。横断研究で因果は区別できない。訓練時間の外での過ごし方まで見る意味づけの材料になる。

出典 [Physiother Res Int](#) ↗

短 信

〈術後リハ〉乳房再建後のPT、早期開始で回復が早い

15研究1,020人のSR。術後2週以内の開始で屈曲・外転が早く回復。合併症は増えず、確実性は低 出典 [Aesthet Surg J](#) ↗

〈心リハ〉CABG後のBuerger-Allen運動、血流に差なし

糖尿病のCABG後60人RCT。ABIの群間差なし(交互作用p=0.711)。術後3日の創部痛のみ早く軽減

出典 [Physiother Res Int](#) ↗

〈心不全〉看護師主導のmHealth心リハ、RCTで改善

慢性心不全の12週RCT。歩数・6分間歩行・METs・LVEFが通常ケアより改善。抄録に人数は無い 出典 [ANS Adv Nurs Sci](#) ↗

〈心血管〉階段昇降で心血管死RR0.61

9研究48万人のメタ解析。5研究で心血管死RR0.61、全死亡RR0.76。観察研究センターで因果は不明

出典 [Am J Cardiovasc Drugs](#) ↗

〈肩〉肩峰下滑液包炎へのブドウ糖注射+運動

46人のパイロットRCT。SPADI差-6.40点で臨床的最小差8点に届かず。重篤な有害事象なし 出典 [Arch Phys Med Rehabil](#) ↗

〈リンパ浮腫〉デジタル併用の複合的理学療法

下肢リンパ浮腫82人の単群試験。患肢体積5,028→4,311mLに減少。対照群がなく因果は言えない 出典 [Disabil Rehabil](#) ↗

〈頭痛〉頸原性頭痛の神経モビライゼーション

5研究142人のスコーピングレビュー。補助として有望だが単独の有効性は示せず 出典 [J Man Manip Ther](#) ↗

〈切断〉回転形成術の約33年後もQOLは良好

33人の横断研究。SF-36 PCS 47.1・MCS 52.2。身体機能のみ一般人口より低下 出典 [J Bone Joint Surg Am](#) ↗